GEHEIME BONUS

Foutenlogboek na de dienst

Registreer na elke dienst zonder jezelf te veroordelen de momenten waarop je iets miste, uitstelde of waarvan je zei «dat scheelde weinig»; zie de patronen en maak dankzij de wekelijkse evaluatie dezelfde fout geen tweede keer.

Inhoud

Waarom een foutenlogboek?

Deel 1 · Wat je registreert

Deel 2 · Oorzaakcategorieën

Deel 3 · Registratiesjabloon (invulbare pagina's)

Deel 4 · 10 reflectievragen

Deel 5 · Wekelijks evaluatieplan

Deel 6 · Maandelijkse patroontabel

Volgende stap

AAN DE SLAG

Waarom een foutenlogboek?

Er bestaat geen AIOS die geen fouten maakt; wel een AIOS die niet van zijn fouten leert.

> *Na een dienst ben je moe en wil je de gemiste bevinding vergeten. Maar die bevinding zit bij de volgende dienst weer op precies dezelfde plek verborgen.*

Dit logboek is geen middel om iemand de schuld te geven. Het doel is niet te achterhalen **wie** de fout maakte, maar **waarom** die gemaakt werd, en je systeem (je beoordelingsvolgorde, je vensters, je communicatie) te versterken.

Privacyregel

Schrijf geen patiëntnaam, protocolnummer, geboortedatum of andere informatie die de patiënt kan identificeren in het logboek. Benoem de casus in algemene termen, zoals «oudere man, CT hersenen, subduraal». Heeft je instelling een systeem voor het melden van incidenten, dan vervangt dit logboek dat niet; meld meldingsplichtige voorvallen ook in het systeem van de instelling.

Regel: 10 minuten

Doe de registratie voordat je de dienst verlaat of zodra je thuis bent, nu het nog vers is. Een korte, eerlijke registratie is beter dan een lange die nooit wordt geschreven.

DEEL 1

Wat je registreert

Niet alleen grote fouten; elk moment dat een leerkans biedt.

TYPE	DEFINITIE	VOORBEELD
Gemiste bevinding	Bevinding die op het beeld staat maar niet in je verslag.	Een dun subduraal hematoom dat je supervisor corrigeerde.
Verkeerde interpretatie	Bevinding die gezien maar verkeerd benoemd werd.	Een fleboliet die als uretersteen werd verslagen.
Bijna-fout (near-miss)	Situatie die werd opgemerkt voordat het een fout werd.	Pneumothorax opgemerkt bij de laatste controle vóór het versturen van het verslag.
Vertraging	Juiste, maar te late beoordeling of melding.	De melding van vrij lucht pas na het verslag gedaan.
Communicatieprobleem	Informatie die de juiste persoon niet op het juiste moment bereikt.	Misverstand bij de clinicus door een vaag geformuleerd verslag.
Protocol / veiligheid	Probleem met de keuze van het onderzoek, contrast of MRI-veiligheid.	Het overslaan van de allergievraag vóór contrast.
Goede vangst	Wat je goed deed en wilt herhalen.	Isodens subduraal hematoom, gevonden door vergelijking met het eerdere onderzoek.

DEEL 2

Oorzaakcategorieën

Koppel elke registratie aan een of meer oorzaken; daaruit komen de patronen naar voren.

CATEGORIE	VRAAG JEZELF AF	MOGELIJKE CORRECTIE
Perceptueel (niet gezien)	Stond de bevinding op het scherm, maar ging mijn blik er niet naartoe?	De vaste beoordelingsvolgorde uitbreiden; de verborgen plekken toevoegen.
Te vroeg stoppen	Stopte ik met doorlopen toen ik de eerste bevinding had gevonden?	De regel «stop niet bij de eerste bevinding»; controle op een tweede bevinding.
Kennistekort	Zag ik de bevinding, maar wist ik niet wat het was?	Het onderwerp bestuderen; herhalen uit de atlas en het woordenboek.
Techniek	Verkeerd venster, ontbrekend vlak, ontbrekende serie?	Checklist voor vensters en reconstructies.
Niet vergelijken	Was er een eerder onderzoek, maar heb ik er niet naar gekeken?	Bij de stap VOORBEREIDEN het eerdere onderzoek verplicht openen.
Klinische informatie	Kende ik de klinische vraag of de voorgeschiedenis niet?	Het aanvraagformulier lezen; zo nodig de clinicus bellen.
Communicatie	Was de melding te laat, onduidelijk of aan de verkeerde persoon gedaan?	SBAR en registratie van de melding.
Systeem en vermoeidheid	Speelden drukte, onderbreking of slaapgebrek een rol?	Na een onderbreking opnieuw beginnen bij het begin van het gebied; pauze; om hulp vragen.

DEEL 3

Registratiesjabloon

Eén formulier per voorval. Je kunt de volgende pagina's afdrukken en vermenigvuldigen.

Schrijf bij het invullen van het formulier de eerste drie regels over de casus en de volgende regels over je eigen proces. De laatste regel is het belangrijkst: wat doe je de volgende keer anders?

Registratie 1

Datum dienst · tijd	
Type (gemist / verkeerde interpretatie / bijna-fout / vertraging / communicatie / veiligheid / goede vangst)	
Casus (geanonimiseerd): leeftijdsgroep, onderzoek, klinische vraag	
Wat is er gebeurd? (objectief, kort)	
Hoe werd het opgemerkt? (ik / mijn supervisor / clinicus / controle)	
Oorzaakcategorie	
Had het gevolgen voor de patiënt? Is het gemeld?	
Wat ik de volgende keer anders doe	

Registratie 2

Datum dienst · tijd	
Type	
Casus (geanonimiseerd)	
Wat is er gebeurd?	
Hoe werd het opgemerkt?	
Oorzaakcategorie	
Gevolgen voor de patiënt · melding	
De volgende keer	

Registratie 3

Datum dienst · tijd	
Type	
Casus (geanonimiseerd)	
Wat is er gebeurd?	
Hoe werd het opgemerkt?	
Oorzaakcategorie	
Gevolgen voor de patiënt · melding	
De volgende keer	

Snelle registratie aan het eind van de dienst (voor meerdere kleine voorvallen in één dienst)

TIJDSTIP	ONDERZOEK	WAT ER GEBEURDE	WAAROM	LES

DEEL 4

10 reflectievragen

Beantwoord na het schrijven van een registratie deze vragen voor het belangrijkste voorval.

1. Waar zat deze bevinding verborgen op het beeld en waarom heb ik daar niet gekeken?

2. Bij welke van de 4 stappen (VOORBEREIDEN · DOORLOPEN · BESCHRIJVEN · SAMENVATTEN) ging het mis?

3. Had ik het juiste venster, de juiste sequentie of het juiste vlak geopend?

4. Was er een eerder onderzoek en heb ik dat vergeleken?

5. Wat had ik moeten weten over de klinische vraag en de voorgeschiedenis?

6. Wanneer zag ik de bevinding voor het eerst en wanneer heb ik die gemeld? Wat gebeurde er tussendoor?

7. Was er een moment waarop ik mijn supervisor had moeten bellen? Waarom belde ik niet, of te laat?

8. Speelden vermoeidheid, drukte of onderbreking een rol bij dit voorval?

9. Welke stap voeg ik toe aan mijn beoordelingsvolgorde om dezelfde fout niet nog eens te maken?

10. Hoe leg ik wat ik van dit voorval heb geleerd in één zin uit aan een collega?

HOOFDSTUK 5

Wekelijks evaluatieplan

Eén sessie per week; de stap die registraties omzet in leren.

1. **Lees de registraties.** Lees alle registraties van de week van begin tot eind; neem ook de snelle registratietabel mee.
2. **Tel de categorieën.** Welke oorzaakcategorie kwam deze week het vaakst terug?
3. **Kies één onderwerp.** Kies voor de bevinding of het gebied dat het vaakst terugkwam één onderwerp om die week te bestuderen.
4. **Ga terug naar het beeld.** Bekijk, indien mogelijk en volgens de regels van je instelling, de beelden van de betreffende casussen opnieuw; vind de bevinding deze keer zelf.
5. **Werk je beoordelingsvolgorde bij.** Voeg zo nodig een stap toe aan je vaste volgorde of een punt aan je checklist.
6. **Deel het met je supervisor.** Bespreek een casus naar keuze kort tijdens de visite of op een geschikt moment.
7. **Schrijf ook de goede vangsten op.** Noteer één ding dat je deze week goed deed; weten wat werkt, is ook leren.

Wekelijks samenvattingsformulier

WEEK	AANTAL REGISTRATIES	MEEST VOORKOMENDE OORZAAK	TE BESTUDEREN ONDERWERP	STAP TOEGEVOEGD AAN MIJN BEOORDELINGSVOLGORDE
1				
2				
3				
4				

HOOFDSTUK 6

Maandelijkse patroontabel

Markeer aan het eind van de maand welke categorieën en gebieden terugkwamen.

OORZAAKCATEGORIE	NEURO	THORAX	ABDOMEN	MUSCULOSKELETAAL	KINDEREN / ZWANGERSCHAP
Perceptueel					
Te vroeg stoppen					
Kennistekort					
Techniek					
Niet vergelijken					
Klinische informatie					
Communicatie					
Systeem en vermoeidheid					

Les van de maand

Onthoud

Een stijgend aantal registraties in je logboek is geen slecht teken; het laat zien dat je zorgvuldiger kijkt. Waar het om gaat, is dat dezelfde oorzaak in de loop van de maand afneemt.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Je logboek is klaar; de cyclus is rond.

Vóór de volgende dienst **«Dienstprotocol: 50 spoedscenario's»** Open het bestand (Hoofdmateriaal) opnieuw en neem de scenario's door van het gebied dat het vaakst in je logboek voorkomt. Je staat er niet alleen voor tijdens je dienst.